Thoát vị đĩa đệm: dẫn lưu bạch huyết có thể hỗ trợ ở đâu?

Thoát vị đĩa đệm không phải lúc nào cũng chỉ gây đau tại lưng. Khi đĩa đệm ảnh hưởng đến rễ thần kinh, người bệnh có thể đau lan, tê, căng cứng và khó vận động. MLD không thể "đẩy" đĩa đệm trở về vị trí cũ hay xử lý nguyên nhân chèn ép thần kinh. Vậy dẫn lưu bạch huyết có thể hỗ trợ ở đâu trong quá trình chăm sóc và phục hồi thoát vị đĩa đệm?

1. HỖ TRỢ GIẢM PHÙ Ở MÔ NGOẠI VI KHI CÓ

Khi nhắc đến thoát vị đĩa đệm, nhiều người thường nghe nói về tình trạng viêm hoặc phù quanh rễ thần kinh. Đây là những thay đổi có thể góp phần gây đau và kích thích thần kinh, bên cạnh tác động cơ học của khối đĩa đệm thoát vị.

Tuy nhiên, phản ứng viêm quanh rễ thần kinh không giống với tình trạng phù ở các mô ngoại vi như phù tay, chân hoặc những vùng mô mềm khác. Rễ thần kinh nằm sâu trong cấu trúc cột sống, trong khi MLD chủ yếu được sử dụng để hỗ trợ sự vận chuyển dịch qua hệ bạch huyết ở các mô ngoại vi.

Vì vậy, không nên hiểu rằng thực hiện MLD trên vùng lưng sẽ trực tiếp đưa dịch viêm quanh rễ thần kinh ra ngoài, làm giảm kích thước khối thoát vị hoặc giải phóng sự chèn ép.

Trong trường hợp người bệnh thoát vị đĩa đệm đồng thời có tình trạng phù mô ngoại vi do một nguyên nhân khác, MLD có thể được cân nhắc nếu nguyên nhân gây phù đã được đánh giá và không có chống chỉ định. Khi đó, mục tiêu chăm sóc là tình trạng phù đi kèm, chứ không phải điều trị đĩa đệm thoát vị.

Đây là sự phân biệt quan trọng để tránh kỳ vọng sai về khả năng tác động của MLD đối với những tổn thương nằm sâu trong cột sống.

2. GIÚP GIẢM CẢM GIÁC CĂNG VÀ NẶNG

Người bị thoát vị đĩa đệm thường có xu hướng thay đổi tư thế hoặc hạn chế một số động tác để tránh làm cơn đau tăng lên. Khi tình trạng này kéo dài, vùng lưng và các cơ xung quanh có thể trở nên căng cứng, mỏi và khó chịu.

Cảm giác căng nặng ấy không nhất thiết xuất phát từ sự tích tụ dịch bạch huyết. Nó còn có thể liên quan đến phản ứng bảo vệ của cơ, tình trạng đau kéo dài, giảm vận động hoặc những thay đổi trong cách cơ thể phân bố lực khi sinh hoạt.



Ảnh 1. Cảm giác căng và khó chịu vùng lưng

Khác với massage mô sâu, MLD sử dụng các chuyển động nhẹ, chậm và có kiểm soát trên da. Vì không nhằm tạo lực mạnh lên cơ hay cột sống, kỹ thuật này có thể mang lại cảm giác dễ chịu đối với một số người khi được thực hiện phù hợp.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa cảm giác dễ chịu sau chăm sóc và hiệu quả điều trị thoát vị đĩa đệm. Hiện chưa có đủ nghiên cứu lâm sàng trực tiếp để khẳng định MLD giúp giảm đau lưng hoặc giảm căng cơ do thoát vị đĩa đệm một cách đáng tin cậy.

Do đó, nếu được lựa chọn, MLD chỉ nên đóng vai trò chăm sóc hỗ trợ, không thay thế việc đánh giá và xử lý nguyên nhân gây đau.

3. GIÚP CƠ THỂ THƯ GIÃN

Đau lưng kéo dài có thể ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của cuộc sống. Không ít người cảm thấy khó tìm được tư thế nghỉ ngơi thoải mái, dễ mệt mỏi hoặc thường xuyên căng thẳng vì lo ngại những cơn đau tái phát.

Khi cơ thể liên tục phải đối mặt với cảm giác đau, việc thả lỏng đôi khi cũng trở nên khó khăn hơn. Người bệnh có thể vô thức gồng cơ hoặc hạn chế cử động ngay cả khi đang nghỉ ngơi.

Một đặc điểm của MLD là các chuyển động nhẹ nhàng, chậm và có nhịp điệu. Trong quá trình thực hiện, một số người có thể cảm thấy thư giãn, bớt căng thẳng hoặc dễ chịu hơn.

Dù vậy, cảm giác thư giãn này không có nghĩa MLD đang làm giảm chèn ép thần kinh hay chữa lành tổn thương đĩa đệm. Đây chủ yếu là trải nghiệm có thể xuất hiện trong quá trình chăm sóc, và mức độ cảm nhận sẽ khác nhau giữa từng người.

Với người đang phục hồi sau những đợt đau kéo dài, một phương pháp chăm sóc tạo cảm giác thoải mái có thể có giá trị nhất định. Nhưng giá trị ấy cần được đặt đúng vị trí, không nên đồng nhất với tác dụng điều trị bệnh lý cột sống.

4. GIÚP VẬN ĐỘNG THOẢI MÁI HƠN

Trong nhiều trường hợp thoát vị đĩa đệm, duy trì hoạt động phù hợp và thực hiện chương trình phục hồi chức năng có vai trò quan trọng. Tùy tình trạng, người bệnh có thể được hướng dẫn những bài tập nhằm cải thiện khả năng vận động, sức mạnh cơ và mức độ chịu tải của cột sống.



Ảnh 2. Vận động và phục hồi chức năng

Tuy nhiên, khi đang đau hoặc căng cứng, người bệnh đôi khi cảm thấy e ngại vận động. Những động tác đơn giản như đứng lên, đi bộ hoặc thay đổi tư thế cũng có thể trở nên khó chịu.

Nếu người bệnh đồng thời có tình trạng phù mô ngoại vi được kiểm soát tốt hơn, hoặc cảm thấy thư giãn sau một buổi chăm sóc nhẹ nhàng, họ có thể chủ quan cảm nhận việc vận động dễ chịu hơn. Dù vậy, chưa có đủ bằng chứng để kết luận MLD trực tiếp cải thiện khả năng vận động ở người thoát vị đĩa đệm.

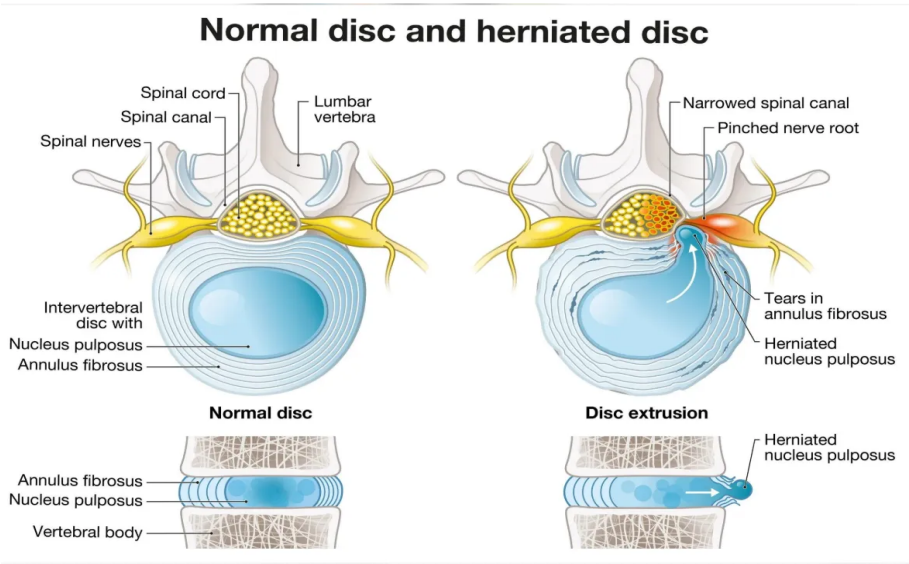
Điều quan trọng là không để cảm giác dễ chịu tạm thời trở thành lý do bỏ qua chương trình phục hồi đã được hướng dẫn. Việc lựa chọn bài tập, điều chỉnh mức độ vận động và theo dõi các triệu chứng thần kinh vẫn cần dựa trên đánh giá chuyên môn.

Nếu MLD được sử dụng, phương pháp này nên được xem là một phần chăm sóc bổ trợ khi có chỉ định phù hợp, thay vì trở thành trọng tâm của quá trình điều trị thoát vị đĩa đệm.

5. KHÔNG ĐƯA ĐĨA ĐỆM TRỞ LẠI VỊ TRÍ CŨ

Đây là giới hạn quan trọng nhất cần hiểu khi nói đến MLD và thoát vị đĩa đệm.

Đĩa đệm nằm giữa các thân đốt sống, có vai trò phân bố lực và hỗ trợ sự vận động của cột sống. Khi một phần vật chất đĩa đệm dịch chuyển ra ngoài giới hạn bình thường, nó có thể gây kích thích hoặc chèn ép những cấu trúc thần kinh lân cận.



Ảnh 3. Đĩa đệm bình thường và đĩa đệm thoát vị

MLD không tác động trực tiếp đến cấu trúc đĩa đệm theo cách có thể đưa phần thoát vị trở lại vị trí ban đầu. Kỹ thuật này cũng không có khả năng giải phóng sự chèn ép rễ thần kinh, sửa chữa tổn thương đĩa đệm hoặc thay thế những phương pháp điều trị chuyên khoa.

Một số trường hợp thoát vị đĩa đệm có thể cải thiện theo thời gian nhờ quá trình hồi phục tự nhiên và điều trị bảo tồn phù hợp. Tuy nhiên, không nên quy những thay đổi đó cho MLD nếu không có bằng chứng xác đáng.

Việc điều trị cần dựa trên biểu hiện thực tế của người bệnh, bao gồm mức độ đau, tình trạng đau lan, cảm giác tê bì, sức cơ, phản xạ và khả năng thực hiện các hoạt động hằng ngày.

Vì vậy, thay vì đặt câu hỏi MLD có thể "chữa thoát vị" hay không, cần xác định rõ người bệnh đang gặp vấn đề gì và liệu có một mục tiêu chăm sóc riêng biệt nào thực sự phù hợp với MLD.

KHI NÀO CẦN ĐI KHÁM?

Không phải mọi cơn đau lưng đều nguy hiểm, nhưng cũng không nên mặc định rằng đau kéo dài chỉ cần massage hoặc nghỉ ngơi là đủ.

Nếu đau lưng thường xuyên tái phát, đau lan xuống chân, tê bì kéo dài hoặc ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt, người bệnh nên được bác sĩ đánh giá để xác định nguyên nhân và lựa chọn hướng điều trị phù hợp.

Đặc biệt, khi xuất hiện yếu chân mới hoặc ngày càng tăng, việc đi lại trở nên khó khăn rõ rệt hoặc các triệu chứng thần kinh tiến triển, cần được thăm khám kịp thời thay vì tiếp tục tự chăm sóc tại nhà.

Một số dấu hiệu cần được đánh giá cấp cứu ngay, bao gồm bí tiểu mới xuất hiện, mất kiểm soát tiểu tiện hoặc đại tiện, giảm cảm giác vùng yên ngựa (quanh tầng sinh môn, bộ phận sinh dục và hậu môn), hoặc yếu chân tiến triển nhanh. Đây có thể là những biểu hiện của hội chứng chùm đuôi ngựa hoặc tình trạng chèn ép thần kinh nghiêm trọng.

Trong những trường hợp này, MLD hay bất kỳ hình thức massage nào cũng không phải lựa chọn xử lý ban đầu. Ưu tiên hàng đầu là được đánh giá y tế để tránh bỏ lỡ thời điểm điều trị cần thiết.

KẾT LUẬN

Thoát vị đĩa đệm là vấn đề liên quan đến cấu trúc cột sống và có thể ảnh hưởng đến các rễ thần kinh. Vì vậy, không thể xem dẫn lưu bạch huyết thủ công là phương pháp điều trị trực tiếp cho tình trạng này.

MLD không đưa đĩa đệm trở lại vị trí cũ, không giải phóng chèn ép thần kinh và chưa có đủ bằng chứng lâm sàng để khẳng định hiệu quả giảm đau hay cải thiện vận động ở người thoát vị đĩa đệm.

Trong những trường hợp được đánh giá phù hợp, MLD có thể được cân nhắc để hỗ trợ tình trạng phù mô ngoại vi đi kèm hoặc mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu trong quá trình chăm sóc. Tuy nhiên, những lợi ích này không nên được hiểu là tác động trực tiếp lên nguyên nhân gây bệnh.

Điều quan trọng không phải là tìm một phương pháp có thể giải quyết mọi triệu chứng, mà là hiểu rõ vấn đề cơ thể đang gặp phải để lựa chọn cách chăm sóc và phục hồi đúng mục đích.

Với thoát vị đĩa đệm, MLD chỉ nên được đặt ở vị trí của một phương pháp hỗ trợ khi thực sự có chỉ định phù hợp, bên cạnh việc điều trị và phục hồi chức năng dựa trên đánh giá chuyên môn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lumbar Disc Herniation – StatPearls, NCBI Bookshelf. Tổng quan về cơ chế thoát vị đĩa đệm thắt lưng, triệu chứng liên quan đến rễ thần kinh, chẩn đoán và điều trị.

Inflammation in Lumbar Disc Herniation – Tài liệu nghiên cứu trên PubMed Central (PMC). Tham khảo vai trò của phản ứng viêm và các chất trung gian gây viêm trong cơ chế đau do thoát vị đĩa đệm.

Manual Lymphatic Drainage in Musculoskeletal Injuries – Systematic Review, PubMed. Tổng quan về MLD trong một số tổn thương cơ xương khớp; không cung cấp bằng chứng trực tiếp để khẳng định hiệu quả điều trị thoát vị đĩa đệm.

International Society of Lymphology – Consensus Document (2023). Tham khảo vai trò của MLD trong quản lý phù bạch huyết và cách phối hợp với các biện pháp điều trị bảo tồn khác.